Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Carazinho

Rua Bento Gonçalves, 151 - Bairro: Vargas - CEP: 99500000 - Fone: (54)3046-9878 - Balcão Virtual: (54) 99681 8308 - Email: frcarazinh2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5009391-36.2022.8.21.0009/RS

AUTOR: MARLEI ROHRIG
RÉU: MUNICÍPIO DE CARAZINHO / RS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I – Relatório (artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil)

MARLEI ROHRIG, qualificada na inicial, ajuizou "AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA" contra **MUNICÍPIO DE CARAZINHO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, igualmente qualificados. Aduziu ter sido acometida por Carcinoma de Bexiga, em estágio avançado, sendo indicado à autora a realização de Imunoterapia com o medicamento Tecentriq 1200 mg, a ser aplicado a cada 21 dias. Asseriu acerca do caráter urgente da utilização da medicação, sob pena de evolução da doença e morte. Requereu, em tutela de urgência, o fornecimento do medicamento, sob pena de bloqueio de valores. Pleiteou, ao final, a procedência da demanda, confirmando a tutela de urgência. Pugnou a gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade judiciária e a tutela de urgência, determinada a emenda à inicial e citados os réus (evento 3, DESPADEC1).

Julgado extinto o feito quanto ao réu INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS, diante de sua ilegitimidade passiva para figurar na ação (evento 26, DESPADEC1).

Citado, o demandado MUNICÍPIO DE CARAZINHO apresentou contestação (evento 54, CONT1). Preliminarmente, requereu a denunciação à lide do IPE-Saúde e a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, deixou de contestar o pedido e discorreu sobre a não incidência dos ônus da sucumbência, o seu ressarcimento, por ter suportado o ônus financeiro. Pleiteou o acolhimento das preliminares e a não condenação aos ônus da sucumbência.

Citado, o réu ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 56, CONT1), no lugar do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE, anteriormente réu na demanda. Discorreu sobre a natureza pública e diferenciada do plano de saúde. Alegou, em suma, que a medicação pleiteada não é coberta pelo plano de saúde, não tendo direito a autora ao tratamento postulado, levando em conta a isonomia com os demais segurados e seu custo. Pleiteou a improcedência da ação.

Réplica ao evento 60, RÉPLICA1.

Em decisão de saneamento e organização do feito, foi afastado o pedido de denunciação à lide, bem como o pedido de inclusão da União. Intimadas as partes sobre as provas que pretendiam produzir (evento 117, DESPADEC1), nenhuma das partes requereu a produção de provas (eventos 119, 120 e 121).

Ministério Público, em parecer de mérito, opinou pela procedência do feito (evento 173, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

II – Fundamentação (artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil)

<u>Do Julgamento Antecipado</u>

Diante dos limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável dilação probatória, sendo suficiente o que já se encontra nos autos. Outrossim, instadas as partes, nenhuma demonstrou interesse na produção de provas. Portanto, cabível o imediato julgamento da lide, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

<u>Do Mérito</u>

O artigo 196 da Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, dever, esse, corroborado também no artigo 198, §1º, e no artigo 23, inciso II, ambos da Carta Magna, bem como no artigo 241 da Constituição Estadual do RS:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. [...]

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000).

Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.

Além disso, a saúde é direito fundamental, elencado como direito social (artigo 6º, *caput,* da Constituição Federal[1]), assim, possui aplicação imediata e incondicionada, na forma do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal[2].

Portanto, é plenamente possível exigir de todos ou de qualquer um dos entes (União, Estado ou Município) - que possuem responsabilidade solidária, conforme decidido no conflito de competência, que delimitou a competência da Justiça Estadual para exame da demanda – os medicamentos nos casos de extrema necessidade e por aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas correspondentes – **como é o caso da autora, considerando que é aposentado pelo IPERGS e recebe mensalmente o valor de R$ 1.696,35 (evento 1, CHEQ5).**

Nessa direção, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente, proferido sob o rito do artigo 543-C do anterior Código de Processo Civil:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ***O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.*** *(RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015).*

Além disso, tal tema foi inúmeras vezes objeto recorrente em julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente ora colacionado:

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. ***Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.*** *Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070).*

Não se pode admitir que o Judiciário ignore o descumprimento da lei, devendo intervir quando impulsionado. Não há, portanto, violação à independência dos poderes quando da concessão de medicamentos judicialmente.

Não fosse por isso, a precária situação no orçamento do Estado não pode justificar a negativa a um direito à saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), que deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS

EMBARGOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA E INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. As despesas com a saúde para pessoas carentes devem correr por conta dos recursos destinados ao fundo de desenvolvimento social do estado (Leis Estaduais 9.908/93 e 9.828/93). Saúde é direito de todos e dever do estado e do município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da c. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- rel. Min. Marco Aurélio). O artigo 196 da Constituição Federal não faz distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e todos, indistintamente, são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, sendo certo que a descentralização, mera técnica de gestão, não importa compartimentar sua prestação. Embargos acolhidos, por maioria. (Embargos Infringentes Nº 70030244370, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 19/06/2009).

AGRAVO. APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público o medicamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de medicamentos a necessitado, devendo responder pelos medicamentos pleiteados no processo. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação ao Município, sendo a Defensoria Pública um órgão do Estado do Rio Grande do Sul e a ação ajuizada também contra Município, ausente confusão entre credor e devedor. Agravo desprovido. (Agravo Nº 70039339122, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/11/2010)

No caso *sub judice,* a demandante demonstrou a necessidade do medicamento postulado em virtude da patologia apresentada, Carcinoma de Bexiga, em estágio clínico III (CID 10 C67), conforme laudo médico do evento 1, ATESTMED2, que ressalta a necessidade da aplicação da medicação Tecentriq 1200 mg continuamente. Insta mencionar que o médico da autora frisou que o medicamento possibilita ganho de sobrevida e qualidade de vida, após já ter realizado tratamento quimioterápico e radioterápico, com recidiva.

Ademais, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a demandante tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão. Por seu turno, não produziu o demandado prova capaz de contrapor o atestado, no sentido de que a autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado

Por oportuno, o referido medicamento possui registro na ANVISA (nº 101000665[3]), **porém, não consta na listagem da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2022 - RENAME[4], não tendo sido incorporado à política do SUS para tratamento da doença da demandante.** Consequentemente, a legitimidade passiva não seria do Estado na presente demanda, afastando a competência da Justiça Estadual, enquadrando-se no item 5º da conclusão do STF. Ainda, friso que, de acordo com o artigo 19-Q da Lei 8.080/90, *"A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS"*. Assim, não competindo aos Estados e aos Municípios a inclusão, por certo que não podem ser obrigados, isoladamente, a custear tratamento sem que tenham a mínima orientação técnica do Ministério da Saúde.

No âmbito do STF, o entendimento mais recente é justamente nesse sentido, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

> *RE n° 1.321.423/RS, Rel. **Min. Dias Toffoli**, julgado em 30/04/2021; ARE nº 1.285.333/PR, Rel. **Min. Gilmar Mendes**, DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel. **Min. Edson Fachin**, DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel. **Min. Roberto Barroso**, DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel. **Min. Alexandre de Moraes**, DJe de 7/1/21.*

No entanto, houve a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) perante o STJ, visando unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas. A delimitação da tese controvertida foi a seguinte:

> *Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.*

Nesse sentido, a Primeira Seção, no julgamento da Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

Dessa feita, procede a presente demanda para, confirmando a tutela de urgência do evento 3, DESPADEC1, determinar que os réus forneçam o medicamento **TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) 1200MG**, na quantia indicada nos atestados, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores para aquisição do medicamento (artigo 538, §3º, c/c artigo 500, ambos do Código de Processo Civil).

Por fim, observando o que estabelece o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde[5], de 15/5/2014, ressalto a necessidade do paciente apresentar relatórios médicos periodicamente perante a Secretaria de Saúde.

III – Dispositivo (artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil)

EM FACE DO QUE FOI EXPOSTO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, *confirmando a tutela de urgência do evento 3, DESPADEC1,* julgo **PROCEDENTE** o pedido aduzido por **MARLEI ROHRIG** contra **o MUNICÍPIO DE CARAZINHO e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para condenar os réus a fornecer solidariamente o medicamento **TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) 1200MG**, de acordo e na quantia indicada nos atestados juntados ao feito, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores. Atente-se ao Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Sucumbente, condeno os réus ao pagamento da Taxa Única e despesas, além de honorários às advogadas da autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, fulcro no artigo 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E (REsp. nº 1.270.439/PR) a partir da publicação desta decisão, acrescidos de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Diante do ajuizamento da presente demanda após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.634/14, ficam os réus isentos da Taxa Única, a teor do artigo 5º, inciso I; isenção que não abarca as despesas processuais (artigo 14 da referida Lei), que deverão restituir em caso de adiantamento pela outra parte, inclusive a título de pagamento da taxa única, fulcro no IRDR 13 do TJ/RS. Ainda, o Estado é isento da condução de Oficial de Justiça (despesa).

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil[6], intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, dê-se vista ao Ministério Público e, então, subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Revendo posicionamento até então adotado, passo a entender que decorrido o prazo para recurso voluntário, sem a sua interposição, **dispensável o reexame necessário**, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos[7].

Referente ao determinado na decisão do evento 213, DESPADEC1, e questionado no evento 222, EMAIL1, deverá a a funcionária da Secretaria de Saúde do Município, Sra. Patricia Dahm dos Santos de Almeida Gomes, alterar a nota fiscal juntada no evento 175, EMAIL1, pág. 7, para constar o nome do Estado do Rio Grande do Sul como destinatário.

Encaminhe-se o arquivo que consta a referida nota fiscal à responsável, para fins de facilitar a correção do erro.

Com o trânsito em julgado, nada mais pendente, dê-se baixa.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação eletrônica agendada.

Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE SUBTIL ELIAS, Juíza de Direito**, em 26/2/2024, às 17:3:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054807557v4** e o código CRC **ababa930**.

---

1. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. ↩
2. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. ↩
3. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351102551201639/ ↩
4. https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf ↩
5. https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2014/05/enunciados_aprovados_jornada_direito_saude.pdf ↩
6. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
7. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 DA CF E 241 DA CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO, AO FADEP. REDUÇÃO. CABIMENTO. [...].. REEXAME NECESSÁRIO: Descabe reexame necessário quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior Competente, consoante determina o parágrafo 3º, do art. 475, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065928178, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROSSO, OSTEOBAN, ARTROLIVE E LYRICA. PACIENTE PORTADORA DE POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA E OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID-10 M15.9 E M81.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO, FORNECIDO PELO SUS. DESCABIMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Reexame necessário. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença que determinou o fornecimento de medicamentos está fundada em decisão do plenário do STF. [...]. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066300096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...].. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066248014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiç Julgado em 08/09/2015) ↩